

vi) マイコプラズマやウイルス感染によるもののほか、Stevens-Johnson 症候群後に生じるものも少ないながら報告がある。

vii) 特発性

散発的に症例報告されているが、非常にまれと考えられる。女性に多い。

症候・身体所見

共通してみられる症状は労作時の息切れで、比較的急性に出現することが多い。ときに咳がみられることもある。症状を自覚するまでに閉塞性障害が相当に進行していることも多い。進行期には気管支拡張が続発し気道感染を頻回に続発する例もある。

聴診所見としては、吸気時の squeak（高調な連続性う音）が特徴的であるが、聴取できない例も多い。

診断・検査

喘息や COPD など、他の閉塞性疾患とは臨床経過が異なる場合に（たとえば非喫煙者に起こる非可逆性進行性の換気制限など）、閉塞性細気管支炎を疑う。

呼吸機能検査において、可逆性がなく比較的急速に進行する閉塞性換気障害が特徴である。拡散能障害を伴うことが多い。

画像診断において胸部 X 線写真は、正常もしくはわずかに過膨張を認める程度で診断には不適である。一方、HRCT は特に吸気時と呼気時の二相で撮影すると診断に有用な mosaic パターンが得られる。閉塞した細気管支の末梢は air trapping のため過膨張となり、また換気の低下による低酸素性血管収縮のため還流も低下する。したがって病変部位の透過性は亢進する。呼気での撮影でより強調されるのが特徴である。また、小葉中心性粒状影がときにみられる。進行例では気管支拡張を呈することもある。

明らかな誘因を指摘できる例（移植後など）では、特徴的な呼吸機能および画像検査所見をもって診断が可能であるが、それ以外の例では確定診断に肺生検による組織診断が必要となる。線維性の閉塞性細気管支

炎の病理所見を得ることが重要ではあるが、病変の分布は斑状で経気管支肺生検（transbronchial lung biopsy : TBLB）での診断は一般的に困難である。そのため侵襲的な検査が可能な場合は外科的肺生検での確定診断が考慮される。

治療と予後

一般的に有症状で発見され閉塞性換気障害が進行している例では、気道の線維性狭窄が進行していると考えられ治療に抵抗性のことが多い。そのため早期診断と誘因の除去が肝要である。

治療は一般的に、①気管支拡張薬や鎮咳薬などの対症療法と、②誘因となる原疾患の治療による閉塞性障害進行抑制が挙げられる。

肺移植・骨髄移植後の閉塞性細気管支炎に関しては、免疫拒絶反応との関連が強いことから一般的に免疫抑制治療の増量や変更が行われる。また肺移植後の閉塞性細気管支炎に関しては疾患進行抑制に対するマクロライド系抗生物質（azithromycin など）内服の有用性が報告されている。

関節リウマチに続発する閉塞性細気管支炎に対しては、ステロイドや抗 TNF- α 製剤の使用が試みられる。また、誘因となりうる薬剤の使用歴の確認も重要である。

閉塞性細気管支炎が疑われ、誘因がはっきりしない場合は職歴や健康食品を含む薬剤使用歴を丹念に聴取して、可能な限りその除去に努めることも肝要である。

進行性で治療に反応しない場合は予後不良である。若年者では肺移植の適応についても検討する。

文 献

- 1) Cordier JF, et al : Thorax 67 : 638, 2007
- 2) Soubani AO, et al : Eur Respir J 29 : 1007, 2007
- 3) Ryu JH, et al : Am J Respir Crit Care Med 168 : 1277, 2003